Traitement des formes métastatiques

À RETENIR

- Métastases à distance : **10 %** ; présentes au diagnostic initial dans **50 %** (synchrones) ; localisations : **os, poumon**.
- Fixation de l'iode 131 dans **2/3** des cas → rémission chez **40 %**.
- Freination : TSH **< 0,1 mUI/l** → amélioration de la survie des patients M1 (évolution hormonodépendante).
- Profil favorable (**1/3**) : fixation, âge **< 40 ans**, petites métastases, tumeur bien différenciée → guérison **40 %**.
- Profil défavorable (**2/3**) : peu/pas de fixation, âge élevé, métastases volumineuses, peu différencié, **fixation FDG élevée** → réfractaire.
- Activité empirique : **3,7–7,4 GBq (100–200 mCi)**, en hypothyroïdie (TSHrh si mauvaise tolérance / déficit thyréotrope).
- Micrométastases pulmonaires : **100 mCi** (enfant **1–1,5 mCi/kg**) tous les **6 mois** pendant **1–2 ans**, puis 1×/an.
- Os : trépied neurologique / fracturaire / douleur ; corticothérapie de couverture ; RTE ; **bisphosphonates +++**.
- Cerveau : chirurgie ou RTE en priorité ; ^{131}I sous corticothérapie, de préférence sous TSHrh.

I. Généralités

- Les métastases à distance représentent **10 %**.
- Présentes au diagnostic initial dans **50 %** des cas (synchrones) ou découvertes au cours de la surveillance.
- Localisation : os, poumon (les plus fréquentes).
- Fixation de l'iode 131 dans **2/3** des cas ; réfractaires : **2/3**.

II. Prise en charge (schéma)

1. **Traitement freinateur** par LT4 : TSH **< 0,1 mUI/l**.
2. **Traitement locorégional**.
3. **Iode** : fixation chez **2/3** des patients → rémission chez **40 %**.
   - Non réfractaire → iode 131.
   - Réfractaire :
     - progressif → traitement par **ITK** ;
     - non progressif → **surveillance**.

1. Traitement locorégional : à envisager systématiquement

- Chirurgie ± embolisation.
- Radiothérapie externe.
- Radiofréquence.
- Cryothérapie.
- Cimentoplastie.

Intérêt :

- guérison rarement obtenue ;
- diminution des symptômes et des complications ;
- association thérapeutique ;
- retarder les traitements systémiques.

2. La freination de la TSH

Visant une TSH **< 0,1** → **amélioration de la survie des patients M1** ; l'évolution est hormonodépendante.

3. Traitement par l'iode 131

Deux groupes de patients avec métastases à distance :

1/3 des patients	2/3 des patients (!)
• Fixation de l'iode 131 • Âge jeune **< 40 ans** • Petites métastases • Tumeur bien différenciée	• Peu ou pas de fixation de l'^{131}I • Âge élevé • Volumineuses métastases • Tumeur peu différenciée • Fixation élevée au FDG (facteur pronostique)
→ Guérison avec l'^{131}I : **40 %** → **96 %** des guérisons obtenues avec une activité accumulée de **600 mCi** au moins **[à vérifier]** *à vérifier : 96 % des rémissions obtenues avec une activité cumulée ≤ 600 mCi*	→ Réfractaire à l'^{131}I → Si progression selon les critères RECIST → besoin de traitement

III. Pronostic

La mortalité et la morbidité de la maladie métastatique sont liées à :

1. le type histologique initial ;
2. la masse tumorale ;
3. la localisation des métastases ;
4. l'âge ;
5. l'éventuelle perte de fixation de l'iode et la captation du FDG.

IV. Modalités du traitement par l'iode 131

- Après TT, tout patient avec CDT et métastases à distance connues (M1) doit avoir **au moins un traitement par l'iode 131**.
- En cas de fixation extra-cervicale sur la scintigraphie post-thérapeutique, le bilan morphologique doit être complété par :
  1. TDM cervico-thoracique ;
  2. TEP FDG ;
  3. TDM abdomino-pelvienne ;
  4. imagerie de l'encéphale et/ou du rachis.

  → Permet de fixer la stratégie thérapeutique : traitements itératifs par l'iode 131 seul ou en association avec des traitements locorégionaux.

1. Activité thérapeutique

- Activité empirique de **3,7 GBq à 7,4 GBq (100–200 mCi)** préconisée.
- **Approches dosimétriques** peu utilisées : parfois discutées dans les cancers pédiatriques ou chez les patients **> 75 ans**.

2. Méthode de stimulation

- Réalisée **en hypothyroïdie**, sauf cas particuliers.
- En cas de mauvaise tolérance de l'hypothyroïdie et/ou de déficit thyréotrope, la TSHrh peut être utilisée.

V. Indications de l'iode 131 en fonction du site métastatique

A. Poumon

Micrométastases pulmonaires diffuses ou isolées

- Le traitement par ^{131}I est indiqué à **visée curative**, avec répétition des traitements jusqu'à disparition des fixations.
- Activité : A = **100 mCi** ; enfant : **1–1,5 mCi/kg**.
- Les traitements sont à répéter tous les **6 mois** pendant **1 à 2 ans**, puis 1 fois par an ou de façon plus espacée, en fonction de la réponse thérapeutique et de la tolérance.
- Rémission plus fréquente pour les micrométastases.

Macrométastases pulmonaires (lésions supracentimétriques)

- Traitement répété (activité empirique **3,7 à 7,4 GBq** → A = **100–200 mCi**) en sevrage, si les métastases sont fixantes et s'il y a un bénéfice clinique, scintigraphique, morphologique et biologique avéré.

B. Métastases osseuses : rarement traitées de façon complète

1. Le **traitement par ^{131}I** est indiqué :
   - systématiquement accompagné d'un bilan morphologique précis ;
   - évaluation, pour chaque localisation, du **trépied** :
     1. risque neurologique (métastase vertébrale) ;
     2. risque fracturaire (stabilité, zone porteuse) ;
     3. symptomatologie douloureuse.
2. Un **traitement local** de consolidation ou chirurgical d'exérèse avant le traitement par l'iode 131 peut s'avérer nécessaire. A = **100–200 mCi** en sevrage hormonal.
3. **Corticothérapie de couverture** discutée pour prévenir un risque d'aggravation neurologique par le défreinage.
4. **RTE** : peut être indiquée en cas de non-fixation et à visée antalgique, dans la mesure du possible après l'^{131}I.
5. **Bisphosphonates +++** (NB !).

C. Métastases cérébrales

- **Chirurgie ou RTE** à discuter en priorité.
- Le traitement par ^{131}I, s'il est indiqué, sera encadré d'une **corticothérapie** au moment de l'administration de l'iode 131, sur des localisations contrôlées sur le plan neurologique.
- Sevrage adapté au cas par cas ; **TSHrh ++** pour éviter l'œdème et l'hypertrophie des cellules induits par le sevrage.
- Nombre de métastases : métastase unique ; oligométastases : **3–7** ; multiples : **> 7**.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Fréquence des métastases à distance des CDT et proportion synchrones ?	10 % ; 50 % présentes au diagnostic initial.
2. Objectif de TSH chez un patient M1 et intérêt ?	TSH < 0,1 mUI/l → amélioration de la survie (évolution hormonodépendante).
3. Caractéristiques du groupe de bon pronostic sous iode ?	Fixation de l'iode, âge < 40 ans, petites métastases, tumeur bien différenciée → guérison 40 %.
4. Bilan à compléter devant une fixation extra-cervicale post-thérapeutique ?	TDM cervico-thoracique, TEP FDG, TDM abdomino-pelvienne, imagerie encéphale/rachis.
5. Activité et rythme pour des micrométastases pulmonaires ?	100 mCi (enfant 1–1,5 mCi/kg), tous les 6 mois pendant 1–2 ans puis 1×/an.
6. Quel est le trépied d'évaluation d'une métastase osseuse ?	Risque neurologique, risque fracturaire, douleur.
7. Précautions pour l'iode 131 en cas de métastases cérébrales ?	Chirurgie/RTE en priorité ; corticothérapie ; TSHrh de préférence (éviter l'œdème du sevrage).
8. Citez 5 traitements locorégionaux des métastases.	Chirurgie ± embolisation, RTE, radiofréquence, cryothérapie, cimentoplastie.